

11. Prescripción rápida: fármacos y terapia física

Usar la dosis mínima eficaz, durante el menor tiempo posible, y registrar función objetivo. Comprobar alergias, embarazo, riñón, hígado, úlcera, anticoagulación, HTA/IC y medicación concomitante.

Opción	Uso orientativo	Guardarraíl
Paracetamol	Rescate breve cuando AINE no es apropiado; 500-1.000 mg cada 8 h según paciente.	Máximo conservador 3 g/día; reducir/evitar en hepatopatía, alcohol de riesgo o fragilidad. No confiar como monoterapia eficaz en OA/lumbalgia.
AINE tópico	Primera opción farmacológica en OA de rodilla y dolor periférico superficial.	Revisar piel, anticoagulación/riesgo sistémico y duplicidad con AINE oral.
AINE oral	Ibuprofeno 400 mg/8 h o naproxeno 250 mg/12 h, habitualmente 3-7 días, si es seguro.	No combinar AINE; valorar IBP. Evitar/individualizar en ERC, úlcera, IC, HTA descontrolada, anticoagulación.
Duloxetina	Dolor neuropático/nociplástico crónico seleccionado: 30 mg/d y valorar 60 mg/d.	No es pauta rutinaria para ciática aguda; vigilar tolerancia, TA, hígado e interacciones serotoninérgicas.
Amitriptilina	Dolor neuropático y sueño: inicio bajo, p. ej. 10 mg nocturno, titulación lenta.	Carga anticolinérgica, QT, glaucoma, retención; precaución especial en mayores.
Gabapentinoides	Reservar para indicaciones neuropáticas apropiadas, con ajuste renal.	No ofrecer de rutina para ciática; sedación, edema, caídas, dependencia/retirada gradual.
Opioides	Excepcional rescate agudo con fecha de fin.	Evitar en dolor musculoesquelético crónico y combinar con sedantes.

Terapia	Dónde encaja	Dónde no
Fisioterapia activa	Base en OA, manguito, GTPS, columna; sesiones según complejidad y programa domiciliario medible.	No prescribir "10 sesiones" sin objetivos, progresión ni reevaluación.
ESWT	Tendinopatía calcificante del manguito y algunas tendinopatías crónicas seleccionadas.	No es tratamiento estándar de radiculopatía, estenosis ni OA intraarticular.
EMTT / Magnetolith	Coadyuvante opcional; un RCT reciente sugiere beneficio corto en varios trastornos degenerativos.	Evidencia aún pequeña/heterogénea; no prometer regeneración ni sustituir ejercicio.
Terapia inductiva / PEMF	Puede modular dolor en algunos pacientes; considerar si bajo riesgo y objetivo claro.	No debe retrasar diagnóstico, carga progresiva o derivación.